

## DISNEA

Manuel Martín Regidor, Sara Raposo García, Abel García del Egido

### INTRODUCCIÓN

Se define como sensación subjetiva de falta de aire o dificultad para poder respirar.

| Causa cardiovascular     | Causa respiratoria                          | Otras causas                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Insuficiencia cardíaca   | Broncoespasmo                               | Anemia                                       |
| Cardiopatía isquémica    | Tromboembolismo pulmonar                    | Acidosis                                     |
| Patología del pericardio | Neumotórax                                  | Fármacos                                     |
| Miocarditis              | Infección respiratoria                      | Desórdenes psiquiátricos (ansiedad)          |
| Arritmias                | Patología obstructiva crónica (EPOC / Asma) | Alteraciones abdominales (ascitis a tensión) |
| Valvulopatías            | Obstrucción de vías aéreas superiores       |                                              |
|                          | Enfermedades intersticiales                 |                                              |
|                          | Distrés respiratorio                        |                                              |
|                          | Afectación de la musculatura respiratoria   |                                              |

### DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

#### MANEJO

Ante un paciente con disnea se debe efectuar una sistemática concreta.

##### Constantes vitales

Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de O<sub>2</sub>.

Constituye una aproximación inicial que aporta una idea de la gravedad del paciente.

##### Antecedentes personales

- Antecedentes alérgicos.
- Exposición a tóxicos: tabaco, polvos inorgánicos, productos químicos.
- Exposición a fármacos.
- Antecedentes de atragantamientos.
- Antecedentes cardiológicos: insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, valvulopatías, arritmias.
- Antecedentes neumológicos: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, enfermedades intersticiales.
- Situaciones de riesgo tromboembólico: cirugía, inmovilización, neoplasias activas.

##### Anamnesis dirigida

Detallar las características de la disnea, la cronología, modificación de la misma con cambios posturales, tipo persistente o intermitente, modo de instauración (progresiva o súbita) y síntomas acompañantes (tos, expectoración, dolor torácico, fiebre... etc.).

Interrogar por el **dolor torácico** y sus características (mecánicas, pleuríticas o isquémicas).

Preguntar si la disnea se **modifica con alguna maniobra o circunstancia** (cambios posturales, esfuerzo).

Valorar otros síntomas concomitantes: **ortopnea, disnea paroxística nocturna** u **oliguria**.

#### Signos de alarma ante una disnea

- Inestabilidad hemodinámica: hipotensión, taquicardia, mala perfusión periférica.
- Signos de obstrucción grave de la vía aérea: estridor, tiraje, hipofonesis, cianosis.
- Glasgow menor de 15.
- Taquipnea extrema (>30 respiraciones por minuto) con tiraje (empleo de musculatura accesoria).
- Desaturación de oxígeno (Sat O<sub>2</sub> <90%).
- Dolor torácico asociado o síncope.

En estos supuestos será necesario realizar un ingreso hospitalario y, en algunos casos, se requerirá valoración por la Unidad de Cuidados Intensivos.

#### Exploración física

En primer lugar se debe valorar el **estado general del paciente**: nivel de consciencia, si presenta disnea con el habla, signos de dificultad respiratoria (como el tiraje, estridor o el empleo de musculatura accesoria), malformaciones torácicas e incluso la coloración de la piel.

- **Cabeza y cuello**: presión venosa yugular (elevada en la insuficiencia cardíaca), reflujo hepatoyugular (sugiere insuficiencia cardíaca), tiraje supraclavicular.
- **Auscultación cardíaca**: ritmo (rítmico o arritmico), frecuencia cardíaca, soplos (valvulopatía), roce pericárdico (derrame pericárdico, pericarditis).
- **Auscultación pulmonar**: murmullo vesicular, (normal, disminuido o abolido -en situaciones de broncoespasmo grave, obstrucción de las vías superiores, derrame pleural o neumotórax-). Sibilancias (broncoespasmo). Roncus (secreciones en la vía aérea). Crepitantes (húmedos en la insuficiencia cardíaca y en la neumonía; secos en enfermedades pulmonares intersticiales). Espiración alargada (patología obstructiva -EPOC/asma-).
- **Abdomen**: la obesidad, la ascitis a tensión o las masas abdominales pueden generar disnea.
- **Extremidades inferiores**: edemas, pulsos periféricos, coloración, cambios tróficos, trombosis venosa.

#### Pruebas complementarias

- Gasometría arterial:
  - pH (7,35-7,45): valores inferiores a 7,35, junto con CO<sub>2</sub> elevado, indica acidosis respiratoria.
  - pCO<sub>2</sub> (35-45 mmHg): valores inferiores a 35 mmHg indican hiperventilación; superiores a 45 mmHg sugieren hipoventilación.
  - pO<sub>2</sub> (>80 mmHg): valores <80 mmHg indican hipoxemia; por debajo de 60 mmHg se considera insuficiencia respiratoria.
  - HCO<sub>3</sub> (24 + 2 mEq/L): si se encuentra elevado orienta a cronicidad de la insuficiencia respiratoria (se eleva de manera compensadora).
- Pruebas de imagen: la radiografía de tórax es clave para orientar el diagnóstico etiológico de la disnea. Valorar silueta cardíaca, consolidaciones, afectación intersticial, derrame pleural, masas, neumotórax, hiperinsuflación, aplanamiento de diafragma, redistribución vascular a campos superiores.
- ECG: alteración de la frecuencia cardíaca, arritmias, signos de isquemia o necrosis, alteraciones del voltaje (alto en hipertrofia ventricular izquierda, bajo en derrame pericárdico), signos de sobrecarga (S<sub>I</sub>Q<sub>III</sub>T<sub>III</sub> -TEP-).

- Hemograma, bioquímica y coagulación: Anemia, leucocitosis, alteración de pruebas hepáticas, TSH, reactantes de fase aguda, ProBNP.
- Otras: angioTC torácico, gammagrafía de ventilación/perfusión, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, espirometría.

### TRATAMIENTO INICIAL

- Asegurar vía aérea, ventilación y estabilidad hemodinámica.
- Oxigenoterapia para Saturación de O<sub>2</sub> >90%.
- Tratamiento etiológico, siempre que sea posible.

| Etiología                              | Tratamiento                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obstrucción de vías aéreas superiores  | Tratamiento endoscópico inmediato.<br>Alternativa: traqueotomía urgente.<br>Espasmo: esteroides, adrenalina.                                       |
| Insuficiencia cardíaca / EAP           | Diuréticos, oxígeno, control estricto de presión arterial, tratamiento etiológico y de los factores desencadenantes.                               |
| Neumonía                               | Antibioterapia empírica. Oxígeno.                                                                                                                  |
| TEP                                    | Anticoagulación inmediata, oxígeno.<br>En caso de TEP masivo e hipotensión: fibrinólisis.                                                          |
| Crisis asmática                        | Oxígeno, broncodilatadores, corticoterapia a dosis altas.                                                                                          |
| Neumotórax, hemotórax, derrame pleural | Tratamiento etiológico, oxígeno, drenaje (en caso necesario).                                                                                      |
| Reagudización de EPOC                  | Antibioterapia empírica, broncodilatadores, corticoterapia, oxígeno (VMNI en caso de acidosis respiratoria -PaCO <sub>2</sub> elevado y pH bajo-). |
| Distrés respiratorio del adulto        | Oxígeno, manejo cuidadoso de la fluidoterapia, corticoterapia, intubación en caso necesario.                                                       |

### BIBLIOGRAFÍA

- Gutiérrez Rodero, F. and García Díaz, J. (1991). *Manual de diagnóstico y terapéutica médica*. 7th ed. Madrid: Universidad Complutense, Departamento de Medicina Interna, Hospital 12 de Octubre.
- Harrison, T. (2002). *Harrison manual de medicina*. 18th ed. McGraw-Hill.
- Moya Mir, M. (2015). *Urgencias en el Paciente Hospitalizado*. 1st ed. Editorial Médica Panamericana.
- Delorme, S. and Ray, P. (2008). Acute respiratory failure in the elderly: diagnosis and prognosis. *Age and Ageing*, 37(3), pp.251-257.
- Lam, L., Cameron, P., Schneider, H., Abramson, M., Müller, C. and Krum, H. (2010). Meta-analysis: Effect of B-Type Natriuretic Peptide Testing on Clinical Outcomes in Patients With Acute Dyspnea in the Emergency Setting. *Annals of Internal Medicine*, 153(11), p.728.
- Malas, Ö., Çağlayan, B., Fidan, A., Öcal, Z., Özdoğan, S. and Torun, E. (2003). Cardiac or pulmonary dyspnea in patients admitted to the emergency department. *Respiratory Medicine*, 97(12), pp.1277-1281.